



Instituto para las Neurociencias & la Salud

Temas a tratar

Situaciones de entrega de informes



Recomendaciones segundas citas y aplicación de COCIENTE INTELECTUAL

Niños:

- En condición ideal se debe iniciar con CI en los niños (descartar condición global de aprendizaje).
- Segunda cita sí:**
 - La aplicación del CI no da suficiente información para dar una conclusión diagnóstica (p.e. sospecha trastorno del aprendizaje). Se debe concluir la evaluación del CI e indicar los hallazgos y por qué no es concluyente?
 - Si explícitamente el profesional remitente solicita evaluación con pruebas complementarias y lo amerita el M.C.
 - No se aplica CI si ya lo trae de otra institución y se confirma validez de evaluación. Se aplica evaluación cognitiva.

Adultos:

- CI Sí: Se trata de proceso legal para pensión, se sospecha por M.C. y antecedentes de discapacidad no diagnosticada/Control de discapacidad.
- Segunda cita sí: la aplicación del protocolo no da suficiente información para dar una conclusión diagnóstica. Se inició con CI y se requiere análisis de funcionamiento cognitivo.
- Se requiere protocolo especial por Dx (p.e. EM).
- Cuando por tiempo no se puede terminar el protocolo en una sesión.



Manejo de casos especiales

- Por los protocolos y rutas de atención se debe solicitar:
 - Dirección completa, Nombre completo y edad de madre-padre/acudiente (en el apartado "con quien vive"), nombre del colegio.
- Si hay sospecha de violencia sexual, violencia intrafamiliar y/o de género. EN LOS QUE SEAMOS PRIMER RESPONDIENTE: hacer el reporte.
- Pacientes que tengan un evento de salud durante la consulta.



Manejo de PQRSD



Otros

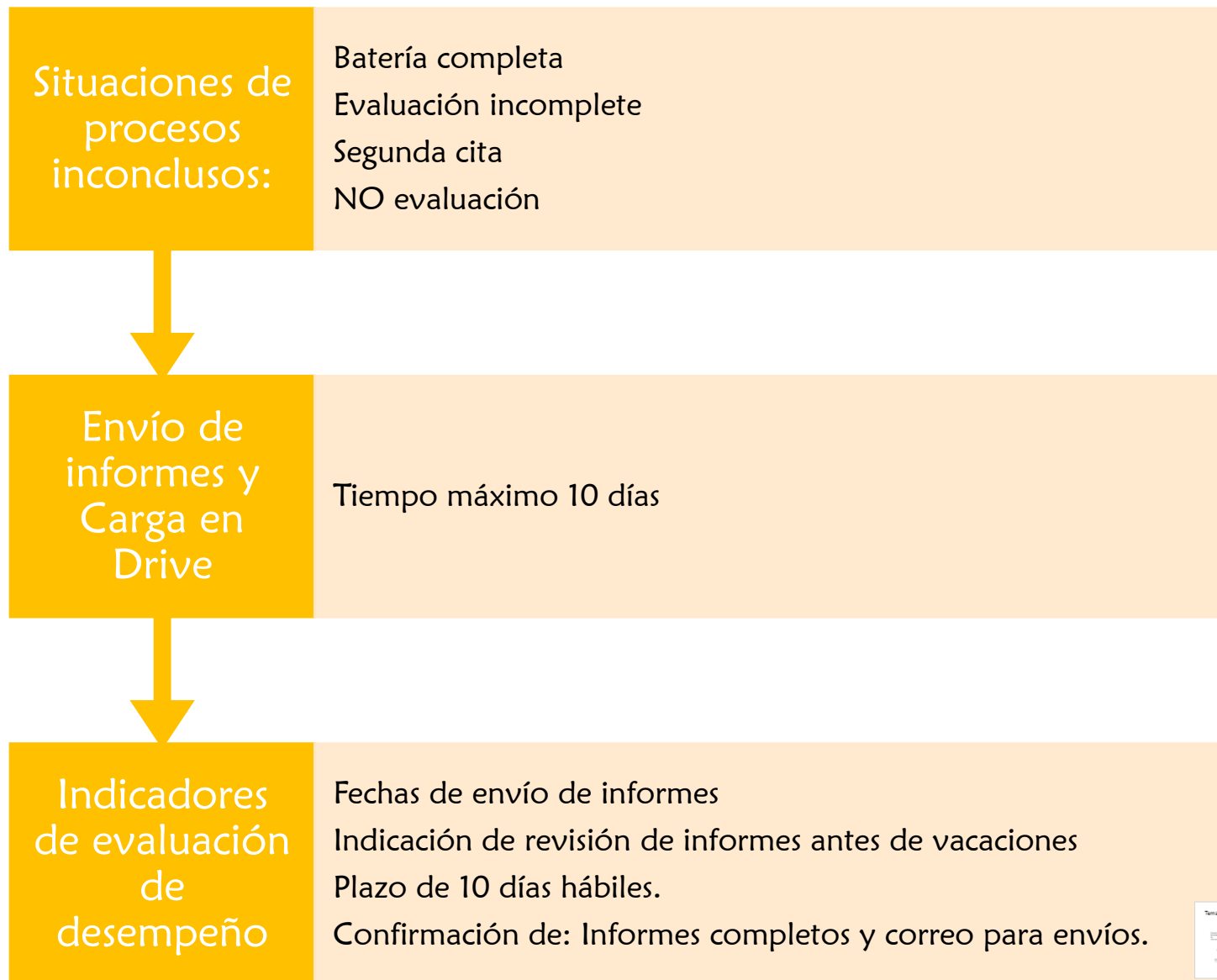
- Verificar fecha de nacimiento.
- Responder el motivo de consulta: Re. si están remitiendo por sospecha de TDAH, yo debo indicar en la conclusión si tiene o NO la condición, así tenga otro dx.
- Respuesta a solicitud de ADI y ADCs: Son una entrevista y evaluación por observación para el dx del TEA, se debe tener certificación en la prueba para aplicarla. Se debe explicar que NO es una prueba neuropsicología y por ende no la aplicamos en el protocolo.
- Espacios de Inasistencia: Cada espacio de Inasistencia es un Ingreso que no recibe IN&S, sin embargo, esto NO impacta el pago de las doctoras (en contratos de prestación o por evento si paga por cada día de atención, no por el tiempo contratado). Se implementó nueva estrategia de confirmación para reducir estos espacios, pues estaban generando impacto económico (del ~10 % al 6 %).
- Se propone el uso de los tiempos destinados a elaboración de Informes (aprox. 10 horas semanales) con separación de uso de computador.
- Aplicación de pruebas necesarias vs. Opcionales. Protocolos alternos (p.e. WISC, Los de adulto mayor).

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ☒ Confirmación de correo
- ☒ Nombres y apellidos bien escritos y en orden
- ☒ Verificación fecha de nacimiento
- ☒ Informes sin casillas en blanco o NA.
- ☒ Análisis completo y que sea versión final
- ☒ Nombre prueba Wechsler (WISC-WAIS-KABC) en apartado Cociente Intelectual
- ☒ Valores coincidentes en texto y gráficos (apartados Cociente Intelectual y en conclusión)
- ☒ Conclusión que responda al motivo de consulta
- ☒ Revisar errores de digitación
- ☒ Hojas de 4 a 9 hojas máximo, con poco margen, sin saltos en blanco



Situaciones de entrega de informes



Situaciones de procesos “inconclusos”

Batería completa, pero segunda orden: (p.e. el WISC) Informe completo hecho con respuesta al MC o aclaración de NO dx.

- ...“Se solicita segunda evaluación pues se requiere el análisis complementario de las funciones cognitivas/dominios escolares para hacer definición diagnóstica”.

Evaluación incompleta: Se deben diligenciar todos los espacios.

- Se diligencia HC completa.
- Pruebas aplicadas se analizan.
- Otras áreas solo con análisis cualitativo, sin sobrepasar lo evidenciado en la consulta, aclarando que no se pudo evaluar con las pruebas: p.e. “Atención: Se identifica un paciente activo y responsivo ante el entorno. Se identifica baja velocidad, sin embargo, no se concluye evaluación de otras áreas de la atención pues no se pudo aplicar protocolo para evaluar cuantitativamente esta función”
- Observación indicando lo evidenciado en consulta
- Conclusión: indicar motivo de NO proceso completo y de segunda cita/Alta voluntaria

Situaciones de procesos “inconclusos”

NO evaluación (por ejemplo, cuando ya traen protocolo aplicado recientemente)

En caso de no poderse realizar evaluación se debe:

- Diligenciar completa la HC, llenar:
- Observación indicando la situación de la consulta y las escalas si se diligenciaron en este apartado.
- Conclusión indicando ¿por qué no se pudo realizar?, la justificación de la situación y/o orientaciones.
- Recomendaciones si aplican.
- Se edita el pdf para eliminar lo que NO se diligenció, dejando solo la HC, observación y conclusiones (en base de datos nueva se podrá generar solo resumen de HC).

Tiempos de entrega y cargue al drive:

- 10 días hábiles

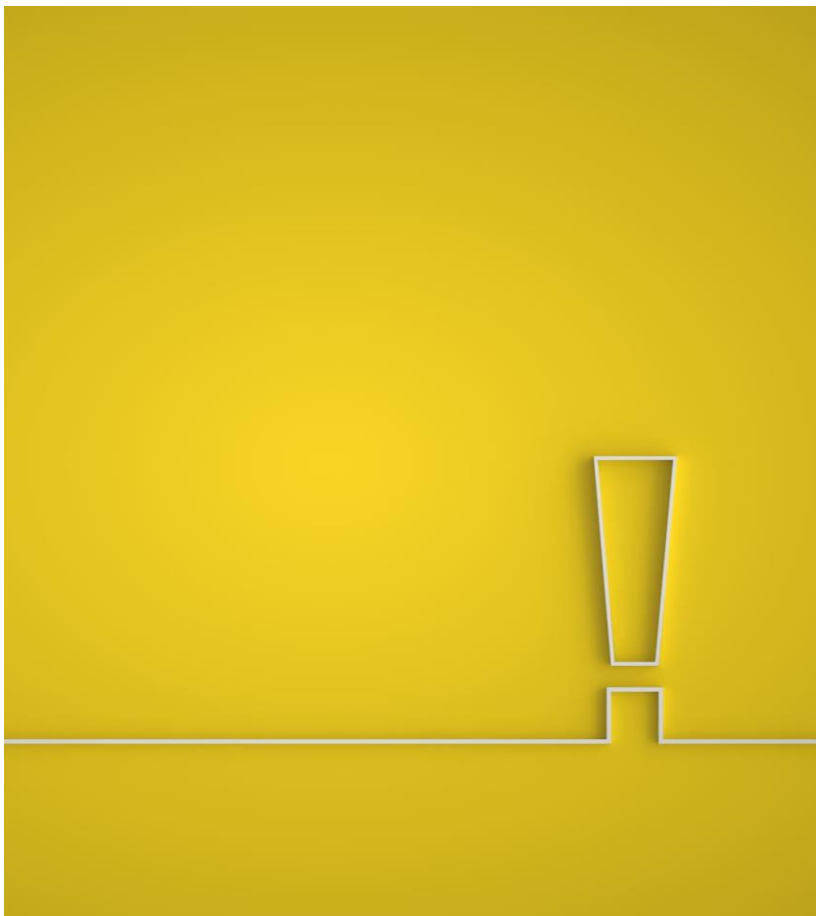
Para las segundas citas



SIEMPRE SE DEBE JUSTIFICAR EN LA CONCLUSIÓN DEL PRIMER EVENTO EL MOTIVO DE LA SEGUNDA CITA.



INDICAR EN LA ORDEN:
S/S PRUEBAS COGNITIVAS
(COD:930102) PARA CULMINAR
PROCESO/PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS PARA DEFINIR
DIAGNÓSTICO. GENERAR CON EL
MISMO PRESTADOR.



Formato posible de Conclusión ante NO evaluación:

Con pruebas recientes p.e.: “Se realiza entrevista y se evidencia que el usuario presenta evaluación neuropsicológica realizada en otra institución en un tiempo menor al estimado para realizar un control. Por este motivo y con el fin de NO sesgar los resultados de la evaluación se hace explicación de los hallazgos presentados (de ser posible), se da orientación y recomendaciones indicando por qué no se puede repetir la evaluación y en cuánto tiempo se debe realizar el control”.

Verificación:

- ❖ NO duplicación de informes en drive y en carpetas (no modificar los nombres de las carpetas del sistema, poner la fecha junto al nombre si son los dos informes de 2 sesiones, SIEMPRE generar el informe desde la BD).
 - ❖ Cada evento de consulta tiene su informe/evolución, que puede ser la HC o el informe parcial o completo.
 - ❖ Informes c/u con la fecha del evento.
 - ❖ NO se debe poner en el Asunto del correo: “Informe parcial”. Se explica en conclusión del evento.
- ❖ ¡OJO!: Envío de informes con evaluación en blanco.
- ❖ ¡OJO!: Envío de informes a correos de otros usuarios o correos equivocados.
- ❖ Medición del indicador del envío de informes en evaluación de desempeño desde 2024. Se debe estar completo el envío antes de vacaciones (indicarles a los usuarios de los días previos, que el envío se hará en 10 días hábiles o que indiquen y prioricen si tienen consultas).

Recomendaciones segundas citas y aplicación de COCIENTE INTELECTUAL

Niños:

- En condición ideal se debe iniciar con CI en los niños (descartar condición global de aprendizaje).
- **Segunda cita sí:**
 - La aplicación del CI no da suficiente información para dar una conclusión diagnóstica (p.e. Sospecha trastorno del aprendizaje). Se debe concluir la evaluación del CI e indicar los hallazgos y ¿por qué no es concluyente?
 - Sí explícitamente el profesional remitente solicita evaluación con pruebas complementarias y lo amerita el M.C.
- No se aplica CI si ya lo trae de otra institución y se confirma validez de evaluación. Se aplica evaluación cognitiva.

Adultos:

- CI Sí: Se trata de proceso legal para pensión, se sospecha por M.C. y antecedentes de discapacidad no diagnosticada/Control de discapacidad.
- Segunda cita sí: la aplicación del protocolo no da suficiente información para dar una conclusión diagnóstica. Se inició con CI y se requiere análisis de funcionamiento cognitivo.
- Se requiere protocolo especial por Dx (p.e. EM).
- Cuando por tiempo no se puede terminar el protocolo en una sesión.

Manejo de casos especiales

- Por los protocolos y rutas de atención se debe solicitar:
 - Dirección completa, Nombre completo y edad de madre-padre/acudiente (en el apartado “con quien vive”), nombre del colegio.
- Si hay sospecha de violencia sexual, violencia intrafamiliar y/o de género, EN LOS QUE SEAMOS PRIMER RESPONDIENTE: hacer el reporte.
- Pacientes que tengan un evento de salud durante la consulta.

Otros

- ❖ Verificar fecha de nacimiento.
- ❖ Responder el motivo de consulta: P.e. Si están remitiendo por sospecha de TEA/TDAH, yo debo indicar en la conclusión si tiene o NO la condición, así tenga otro dx.
- ❖ Respuesta a solicitud de ADI y ADOS: Son una entrevista y evaluación por observación para el dx del TEA, se debe tener certificación en la prueba para aplicarla. Se debe explicar que NO es una prueba neuropsicológica y por ende no la aplicamos en el protocolo.
- ❖ Espacios de inasistencia: Cada espacio de inasistencia es un ingreso que no recibe IN&S, sin embargo, esto NO impacta el pago de las doctoras (en contratos de prestación o por evento se paga por paciente atendido, no por el tiempo contratado). Se implementó nueva estrategia de confirmación para reducir estos espacios, pues estaban generando impacto económico (Del ~10 % al 6 %).
- ❖ Se propone el uso de los tiempos destinados a elaboración de informes (aprox. 10 horas semanales) con separación de uso de computador.
- ❖ Aplicación de pruebas necesarias vs. Opcionales. Protocolos alternos (p.e. WISC, Los de adulto mayor).



LISTA DE VERIFICACIÓN

- ☒ Confirmación de correo
- ☒ Nombres y apellidos bien escritos y en orden
- ☒ Verificación fecha de nacimiento
- ☒ Informes sin casillas en blanco o NA. Análisis completo y que sea versión final
- ☒ Nombre prueba Weschler (WISC-WAIS-KABC) en apartado Cociente Intelectual
- ☒ Valores coincidentes en texto y gráfica (apartados Cociente Intelectual y en conclusión)
- ☒ Conclusión que responda al motivo de consulta
- ☒ Revisar errores de digitación
- ☒ Hojas de 4 a 5 hojas máximo, con poco margen, sin saltos en blanco

Protocolo para la atención de Adulto Mayor

DOMINIOS	PRUEBAS
ESCALAS*	Kertesz/FBI
*Hacerlas a modo de complemento durante la entrevista	Queja Subjetiva de memoria
	Yesavage
	Lawton
ORIENTACION	MMSE (preguntas orientación NO incluir puntaje en la base)
MEMORIA VERBAL	GROBER & BUSCHKE
PRAXIAS	FCRO (Copia)
	TMT A y B
ATENCION	Símbolo-Dígito (SDMT)
	Span directo (dígitos directos y regresión WAIS)
	Instrucciones Conflictivas (INECO)
MEMORIA VISUAL	FCRO (Recobro)
LENGUAJE	Fluidez P y Animales
	Denominación
	Semejanzas
FUNCION EJECUTIVA	Refranes (INECO)
	Stroop
	Go No Go (INECO)

CONDICIÓN	PRUEBAS
	GROBER & BUSCHKE / HVLIT (Según considere)
	FCRO (Copia)
	TMT A
	Span directo (dígitos directos y regresión WAIS)
	Meses atrás (INECO)
	FCRO (Recobro)
	Refranes (INECO)
	Semejanzas
	Recobro GROBER / HVLIT
	Memoria Remota y Reciente
	Fluidez P y Animales
	Denominación

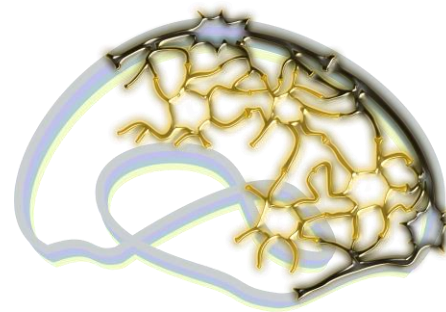
	GROBER & BUSCHKE / HVLIT (Según considere)
	TMT A y B Oral
	Símbolo-Dígito Verbal (SDMT Oral)
	Span directo (dígitos directos y regresión WAIS)
	Dígitos del Neuropsi
	Refranes (INECO)
	Semejanzas
	Recobro GROBER / HVLIT
	Memoria Remota y Reciente
	Fluidez P y Animales
	Denominación
	Stroop

AFECCION MOTORA
(NO hacer FCRO ni praxias
visoconstruccionales, ni test de
trazo o velocidad motora)

DOMINIOS	PRUEBAS
ESCALAS	NPI
	Ansiedad de Hamilton
ATENCION	TMT A - B Oral
	Dígitos del Neuropsi
	Símbolo-Dígito (SDMT) - Oral o de mayor tamaño
MEMORIA VERBAL	HVLIT
	(analfabetas, baja escolaridad, o problemas visuales)
	Memoria Remota
	Memoria Reciente
PRAXIAS	Gesto Simbólico (Orden- mano dominante)
(Orden- mano dominante)	Mímica y uso de objetos (Orden- mano dominante)
	Casa, Margarita, Reloj (Analfabetas o cuando tengan dudas por la ejecución de FCRO o no se pueda realizar)
LENGUAJE	Test de Denominación de Boston (Versión de 60 o de 15 ítems)
	Preguntas de Denominación
	Meses atrás (INECO)
FUNCION EJECUTIVA	Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
	Torre de Londres

CUADRO A-7												
Coeficientes de confiabilidad y validez de las formas cortas de WISC-IV para combinaciones de 2, 3, 4 y 5 subpruebas												
Dos subpruebas			Tres subpruebas			Cuatro subpruebas			Cinco subpruebas			
Forma corta	r _{tt}	r	Forma corta	r _{tt}	r	Forma corta	r _{tt}	r	Forma corta	r _{tt}	r	
VB AR	.928	.879	VB BS AR	.924	.911	SE VB BS AR	.943	.933	SE CL MT AR PC	.955	.949	
DC VB	.916	.874	VB MT AR	.946	.908	VB BS AR PC	.945	.932	CL VB MT AR PC	.957	.949	
SE AR	.917	.874	DC VB AR	.941	.907	SE CL VB AR	.946	.931	VB MT BS AR PC	.955	.949	
VB MT	.926	.873	VB FI AR	.935	.906	SE CL AR PC	.944	.931	SE CL VB MT AR	.956	.948	
VB BS	.884	.863	DC VB NL	.939	.905	SE VB MT BS	.942	.931	SE VB MT BS AR	.954	.948	
DC IN	.905	.861	SE BS AR	.918	.905	SE CL VB MT	.945	.930	DC SE CL VB NL	.953	.947	
SE MT	.916	.860	SE VB BS	.924	.904	SE BS AR PC	.941	.930	SE MT BS AR PC	.953	.947	
AR PC	.926	.860	VB MT BS	.923	.904	VB MT BS IN	.942	.930	DC SE CL VB AR	.954	.946	
IN AR	.920	.858	VB BS IN	.924	.904	VB MT BS AR	.943	.930	DC CL VB AR PC	.955	.946	
MT IN	.917	.857	DC VB IN	.939	.903	VB MT BS PC	.944	.930	SE CL VB FI AR	.952	.946	
NL AR*	.927	.818	SE VB IN	.947	.874	DC SE RD CL*	.932	.909	SE VB CM IN PC	.963	.891	
RD AR*	.915	.779	SE VB PC*	.950	.870	SE VB CM IN	.953	.882				
BS RG**	.841	.583	SE CM IN*	.932	.867	SE VB CM PC	.954	.878				
CL RG**	.871	.517	VB CM IN*	.938	.863	DC CL MT FI**	.939	.858				
			SE CM PC*	.935	.858	RD NL CL BS*	.931	.826				
			VB CM PC*	.942	.854							
			DC MT FI*	.933	.831							
			CL MT FI*	.920	.828							
			DC CL FI*	.915	.823							
			RD NL AR*	.941	.819							
			CL BS CA**	.896	.636							

NIT. 901.192.434-4
CI 90 No. 19-41 Of. 305
Tel: (+57 1) 6941836
Cel: 318-7370049
www.inyscolombia.com
institutonys@gmail.com



IN&S



@Inysco